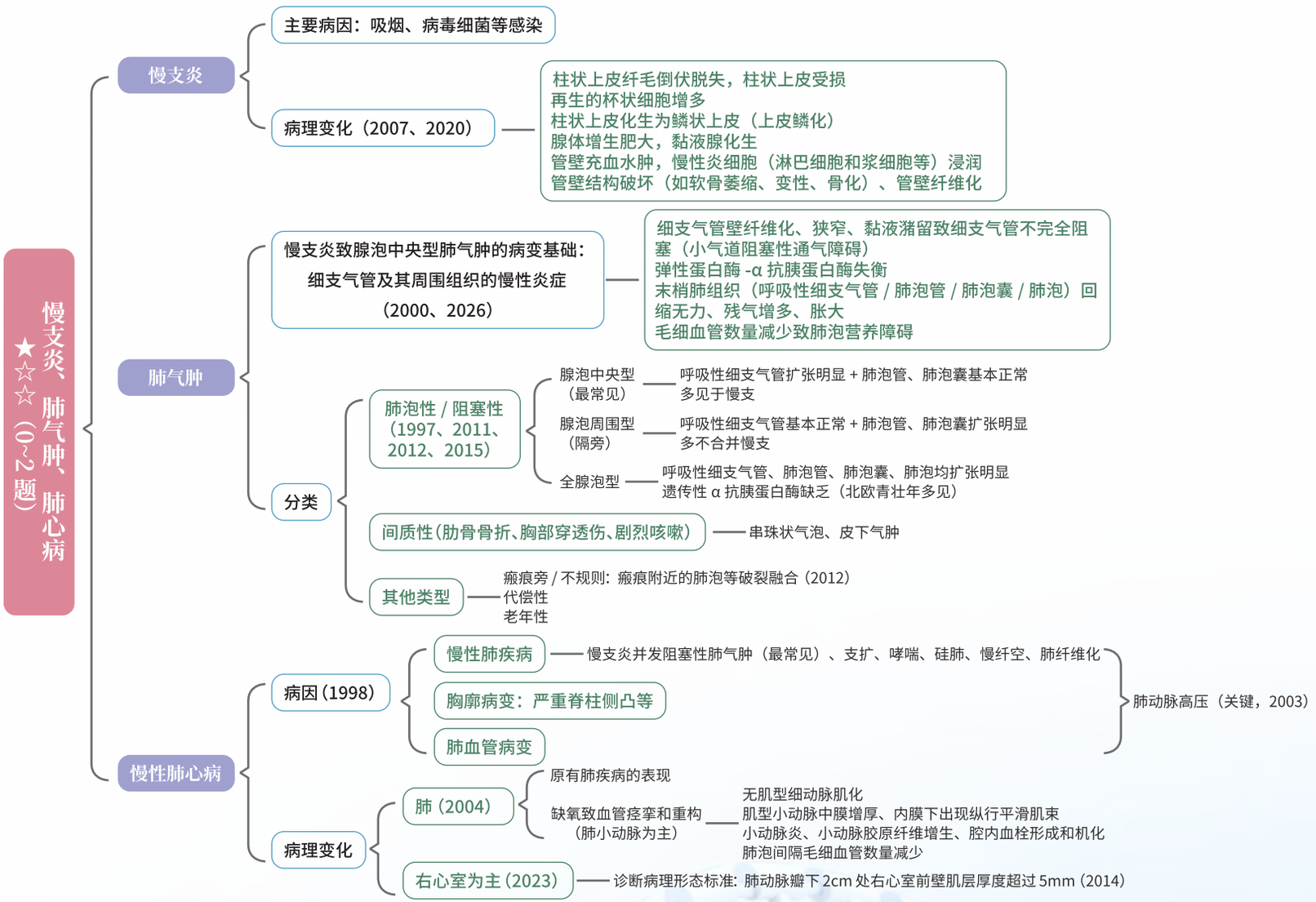

慢支炎、肺气肿、肺心病
★☆☆（0~2题）
慢支炎
主要病因：吸烟、病毒细菌等感染
病理变化（2007、2020）
柱状上皮纤毛倒伏脱失，柱状上皮受损
再生的杯状细胞增多
柱状上皮化生为鳞状上皮（上皮鳞化）
腺体增生肥大，黏液腺化生
管壁充血水肿，慢性炎细胞（淋巴细胞和浆细胞等）浸润
管壁结构破坏（如软骨萎缩、变性、骨化）、管壁纤维化
肺气肿
慢支炎致腺泡中央型肺气肿的病变基础：细支气管及其周围组织的慢性炎症（2000、2026）
细支气管壁纤维化、狭窄、黏液潴留致细支气管不完全阻塞（小气道阻塞性通气障碍）
弹性蛋白酶 -α 抗胰蛋白酶失衡
末梢肺组织（呼吸性细支气管 / 肺泡管 / 肺泡囊 / 肺泡）回缩无力、残气增多、胀大
毛细血管数量减少致肺泡营养障碍
分类
肺泡性 / 阻塞性（1997、2011、2012、2015）
腺泡中央型（最常见）
呼吸性细支气管扩张明显 + 肺泡管、肺泡囊基本正常
多见于慢支
腺泡周围型（隔旁）
呼吸性细支气管基本正常 + 肺泡管、肺泡囊扩张明显
多不合并慢支
全腺泡型
呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡均扩张明显
遗传性 α 抗胰蛋白酶缺乏（北欧青壮年多见）
间质性（肋骨骨折、胸部穿透伤、剧烈咳嗽）
串珠状气泡、皮下气肿
其他类型
瘢痕旁 / 不规则：瘢痕附近的肺泡等破裂融合（2012）
代偿性
老年性
慢性肺心病
病因（1998）
慢性肺疾病
慢支炎并发阻塞性肺气肿（最常见）、支扩、哮喘、硅肺、慢纤空、肺纤维化
胸廓病变：严重脊柱侧凸等
肺血管病变
肺动脉高压（关键，2003）
病理变化
肺（2004）
原有肺疾病的表现
缺氧致血管痉挛和重构（肺小动脉为主）
无肌型细动脉肌化
肌型小动脉中膜增厚、内膜下出现纵行平滑肌束
小动脉炎、小动脉胶原纤维增生、腔内血栓形成和机化
肺泡间隔毛细血管数量减少
右心室为主（2023）
诊断病理形态标准：肺动脉瓣下 2cm 处右心室前壁肌层厚度超过 5mm（2014）